

护士评估结论与调整建议

生成时间：2026-05-18 16:05:03

《护士评估结论与调整建议》

NPI结论：

老人当前NPI评分为15分，属于中度精神行为异常，较住院期（22分）及出院期（16分）持续改善。核心表现为偶发性拒绝配合康复训练及集体活动，无言语或肢体攻击、游走、幻觉等过激行为，情绪整体平稳。BPSD症状处于缓解期，但存在情境性触发风险（如强制参与活动时）。

ADL结论：

ADL评分为70分，属轻度功能障碍。老人可独立完成进食、穿衣、如厕、大小便控制及床椅转移；平地行走及上下楼梯需部分辅助；洗澡需照护员全程协助，主要因动作幅度过大可能影响心脏状态，同时存在跌倒与烫伤风险。

进食评估结论：

进食正常，食欲良好，吞咽功能无异常，无呛咳、误吸表现，营养摄入充足，无需特殊饮食调整或吞咽干预。

睡眠评估结论：

主观报告每晚睡眠7-8小时，规律且无失眠、多梦、早醒等主诉。客观睡眠监测显示夜间离床次数偏多（4-9次），但结合照护记录，多为如厕等生理性需求，未影响整体睡眠质量，暂不视为睡眠障碍。

当前风险判断：

- **BPSD复发风险****：虽当前平稳，但拒绝配合行为仍存在，若照护方式不当（如强制、催促）可能诱发症状反弹。
- **跌倒与烫伤风险****：洗澡过程中如需全程协助且动作控制能力下降，存在高风险；上下楼梯亦需警惕。
- **家属心理应激****：家属对照护效果存疑，焦虑情绪未完全缓解，可能影响照护依从性与沟通效率。
- **循环系统监测需求****：心率长期维持在60次/分（正常下限），虽有起搏器保障，仍需定期评估起搏器功能及药物影响。

护理员调整建议：

- **认知干预优化****：结合老人“喜好跳舞”的特点，每日安排15-20分钟轻柔舞蹈活动（如怀旧舞曲伴奏的坐姿律动），作为非药物BPSD干预手段，提升参与意愿，减少抗拒行为。
- **BPSD预防措施****：采用“选择式引导”代替指令式语言（如“您想现在做康复

，还是半小时后？”）；避免在老人疲惫或情绪低落时安排集体活动；建立“平静角”供其自主调节情绪。

3. ****洗澡安全强化****：严格执行洗澡安全流程——水温预先调试至38-40℃、铺设防滑垫、照护员全程一对一陪护、动作轻柔缓慢，洗澡前评估当日心脏状态。

4. ****家属支持策略****：每周安排1次15分钟家属沟通会，提供《BPSD非药物应对技巧手册》，示范“如何回应拒绝行为”；邀请家属参与一次舞蹈活动，增强其对照护有效性的直观感受。

****是否需要GP介入****：否。当前病情稳定，药物依从性良好，生命体征可控，建议按原计划每3个月复诊，无需紧急医疗介入。

****是否更新护理员任务****：是。需新增基于兴趣的认知活动、家属沟通培训及洗澡安全核查项。

****护理员判断依据****：

- NPI评分持续下降但仍有中度异常；
- ADL明确洗澡为唯一依赖项且具高风险；
- 家属焦虑为照护协同薄弱点；
- 老人跳舞喜好未被充分利用于干预。

****视频规程链接****：

- 《失智老人洗澡安全操作规范》
- 《非药物BPSD干预：兴趣导向活动实施指南》
- 《家属沟通技巧：应对照护焦虑的三步法》

****家属沟通建议****：

主动告知BPSD缓解趋势及当前稳定状态，强调“拒绝行为≠病情恶化”，而是失智症常见表现；邀请家属观看老人参与舞蹈活动的视频片段，增强信心；提供书面《本周照护重点摘要》，包含风险预防措施及家庭可配合事项（如电话问候时避免询问“今天听话了吗？”等评判性语言）。